

4.4. Prevención y control de infecciones

CRITERIO	ORIENTACIÓN	EVIDENCIA SUGERIDA
ESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS		
4.4a) Cuenta con profesionales especializados en control de infecciones.	4a) Se encargan del control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS), al menos - Un médico especialista en infectología y - Un licenciado en enfermería con estudios en epidemiología o egresado de curso de especialización en control de infecciones. En todos los casos, los profesionales cumplen con los Requisitos Previos Obligatorios.	4a) - Dotación de personal asignada al control de infecciones. - Legajos del personal asignado al control de infecciones.
4.4b) Existe un Comité que participa activamente en la elaboración y supervisión de las normas de vigilancia y prevención de las infecciones.	4b) El Comité - Está conformado orgánicamente en la institución, incluyendo sus funciones, responsabilidades e integrantes; - Desarrolla sus actividades en base a un reglamento interno; - Establece un cronograma de reuniones y - Registra sus actividades.	4b) - Conformación del Comité, su reglamento de funcionamiento, cronograma y registro de actividades.
4.4c) Se promueve y facilita la higiene de manos del personal asistencial y no asistencial, pacientes, familiares y público en general, en todas las áreas asistenciales y no asistenciales.	4c) Se entiende por áreas asistenciales todas aquellas en las que el paciente, en situación crítica o no, recibe acciones destinadas a la prevención, diagnóstico y atención de su enfermedad, tanto a nivel clínico como quirúrgico y abarcando las modalidades ambulatoria y de internación.	4c) - Observación directa. - Planos arquitectónicos.

CRITERIO	ORIENTACIÓN	EVIDENCIA SUGERIDA
	Se entiende por áreas no asistenciales todas aquellas en las que se desarrollan tareas no ligadas directamente con la atención y prevención de la enfermedad, promoción ni recuperación de la salud. Ejemplos son las áreas administrativas, de mantenimiento estructural y del equipamiento, de recreación, buffet y otras similares. En este marco, todas esas áreas deben contar con facilidades para la higiene de manos. El tipo y número de facilidades estará adaptado a cada área en particular, pero existen componentes básicos que deben existir en todas ellas. Distribución de las facilidades para la higiene de manos: - Pileta de tamaño y profundidad suficientes para minimizar salpicaduras, agua corriente, jabón, toallas descartables y dispensadores de alcohol al 70%, en los sanitarios destinados al personal, a los pacientes, familiares y al público en general. - Dispensadores de solución hidroalcohólica al 70% distribuidos de manera que estén permanentemente al alcance de los integrantes de los equipos asistenciales (junto a cada cama de internación y en los consultorios de atención ambulatoria, por ejemplo). - Dispensadores de alcohol al 70% distribuidos de manera que estén permanentemente al alcance	

CRITERIO	ORIENTACIÓN	EVIDENCIA SUGERIDA
	de las personas en todas las áreas de circulación (general, restringida y semirrestringida). Se espera que, al momento de la evaluación en terreno, los dispensadores de alcohol al 70% contengan no menos de 1/3 de su capacidad.	
PROCESOS		
4.4d) Existe un Programa de Control de Infecciones.	4d) Este programa tiene como objetivo la reducción de las Infecciones, tanto las Asociadas al Cuidado de la Salud como otras, y del riesgo de eventos adversos que éstas presentan para pacientes, personal y otras personas que concurren al establecimiento [43, 68, 69, 70, 71, 72]. Las normas y sistemas principales del programa son: - Vigilancia epidemiológica. - Uso racional de antibióticos. - Detección y actuación ante la aparición de brotes en la institución. - Mecanismos de respuesta a alertas sanitarias. - Promoción y facilitación de la higiene de manos. - Limpieza, esterilización y procedimientos invasivos. - Aseo del personal de la unidad.	4d) - Programa de Control de Infecciones.

CRITERIO	ORIENTACIÓN	EVIDENCIA SUGERIDA
	- Manejo del material sucio y contaminado de acuerdo a la legislación vigente. - Información periódica del control de infecciones en la institución. - Aislamiento.	
4.4e) Existe un sistema activo y normatizado de vigilancia epidemiológica de las IACS.	4e) El sistema de vigilancia de IACS - Está a cargo de profesionales específicamente dedicados; - Cuenta con normas específicas; - Calcula y comunica periódicamente las tasas obtenidas (incidencia y prevalencia de IACS, uso de dispositivos, etc.), a las áreas involucradas y a la Alta Dirección; - Compara las tasas obtenidas con otras de referencia (PEEC, VIHDA, SATIQ, CDC, etc.). Las normas del sistema establecen: - Sobre qué tipo de áreas (abiertas, cerradas) y casos (clínicos, quirúrgicos), se ejercerá vigilancia; - La vigilancia de posibles vías de entrada como: - o Catéteres vasculares; - o Catéteres urinarios; - o Sistemas de asistencia respiratoria mecánica (ARM); - o Heridas quirúrgicas en cirugías limpias.	4e) - Normas activas del sistema de vigilancia epidemiológica. - De existir, convenios con sistemas externos de benchmarking epidemiológico.

CRITERIO	ORIENTACIÓN	EVIDENCIA SUGERIDA
	- Cuándo y cómo presentar las comunicaciones a la Alta Dirección. - Criterios de infección hospitalaria; - Metodología para la obtención de tasas de infección; - Procedimientos y oportunidades para realizar estudios de prevalencia.	
4.4f) Se presta especial atención a la reducción del riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por sangre y fluidos como la hepatitis, VIH, etc.	4f) Existen protocolos para pacientes positivos tendientes a reducir las posibilidades de contagio a otros pacientes, el personal y visitantes. Estos protocolos se enfocan en - Evitar accidentes con instrumentos cortantes; - Evitar el contacto con elementos contaminados, lesiones de piel abiertas con material potencialmente infeccioso; - Utilización de guantes al manipular sangre, objetos contaminados con sangre o fluidos corporales, como también superficies expuestas a ellos; - Higiene de manos antes y después de utilizar guantes.	4f) - Normas activas para la implementación de prevenciones universales de protección ante enfermedades transmitidas por sangre y fluidos como la hepatitis, VIH, etc.
4.4g) Existe un programa de mejora de la adherencia a la higiene de manos dirigido al personal, pacientes, familiares y público.	4.g) El programa consta de, al menos: - Exposición en lugares visibles al público de recomendaciones y recordatorios sobre la importancia de la higiene de manos;	4.g) - Programa de mejora de la adherencia a la higiene de manos. - Observación directa.

CRITERIO	ORIENTACIÓN	EVIDENCIA SUGERIDA
	- Cartelería con las normas OMS sobre los “5 Momentos de la Higiene de Manos” en todos los puestos de higiene de manos, tanto en áreas asistenciales y no asistenciales; - Actividades permanentes y periódicas de capacitación según criterio 4.4i; - Implementación de actividades de promoción en el Día Mundial de la Higiene de Manos (5 de mayo); - Implementación de mediciones periódicas de la adherencia del equipo asistencial a la higiene de manos según herramientas de la OMS o similares; - Distribución de dispensadores de solución hidroalcohólica al 70% en todas las áreas del establecimiento; - Disponibilidad de agua, jabón y toallas descartables en todos los sanitarios, tanto los destinados al personal, como a los pacientes y al público.	
4.4h) Cuenta con normas activas sobre precauciones para la prevención de IACS.	4h) Las normas deben contener al menos instrucciones acerca de: - Procedimientos de higiene de manos; - Programa de higiene de superficies, (paredes, pisos, equipos médicos, etc.), estableciendo responsabilidades, frecuencias, productos a utilizar según superficie, etc.	4h) - Normas activas sobre precauciones para la prevención de IACS.

CRITERIO	ORIENTACIÓN	EVIDENCIA SUGERIDA
	- Selección, preparación y uso de antisépticos y desinfectantes; - Precauciones universales con sangre y fluidos corporales; - Prevención de infecciones del sitio quirúrgico. - Curación de heridas; - Cuidado de catéteres (intravasculares, urinarios, neurológicos y otros); - Manejo de la vía respiratoria y sus secreciones, en especial en pacientes bajo ARM. - Implementación de paquetes de medidas (bundles), orientadas a reducir la incidencia de infecciones asociadas a dispositivos. - Uso apropiado de equipos de protección personal (EPP). - Técnicas de aislamiento de pacientes infectocontagiosos e inmunocomprometidos.	
4.4i) El uso de antibióticos se halla normatizado.	4i) Se dispone de normas para el uso racional de antibióticos que se actualizan permanentemente y se desarrollan actividades periódicas de capacitación y actualización dirigidas al equipo asistencial, así como de educación para la salud dirigidas a personal no asistencial y público en general.	4i) - Normas activas y actualizadas de uso racional de antibióticos. - Programa de capacitación dirigidas al personal asistencial - Documentación que avale el desarrollo de educación para la salud dirigidas a personal no asistencial y público en general.

CRITERIO	ORIENTACIÓN	EVIDENCIA SUGERIDA
4.4j) Cuenta con normas de profilaxis antibiótica prequirúrgica.	4j) Las normas de profilaxis prequirúrgica establecen, al menos - Qué antibióticos utilizar; - En qué tipo de cirugías; - Quién los debe aplicar; - Cuándo y en qué dosis aplicarlos. - Asignación de responsabilidades de control. Cuando se detecten infecciones, deben existir - Esquemas de tratamiento antibiótico empírico inicial. - Mecanismos de elección de tratamiento definitivo según agente etiológico. En todos los casos se cuenta con ○ Mecanismos de control de resultados en base a información bacteriológica permanente y de revisión periódica. ○ Normas de cambio a tratamiento oral precoz. ○ Decisión de paso a internación domiciliaria.	4j) - Normas activas de profilaxis antibiótica prequirúrgica
4.4k) Desarrolla actividades de detección, tratamiento y prevención de infecciones por organismos multirresistentes a antibioticoterapia (OMRs).	4k) Las actividades de detección, tratamiento y prevención de OMRs (como, por ejemplo <i>Staphylococcus aureus</i> Metilino Resistente, <i>Enterococo</i> Vancomicina Resistente, <i>Klebsiella pneumoniae</i> productora de Carbapenemasa y otros), están basadas en	4k) - Documentación descriptiva de las actividades de detección, tratamiento y prevención de infecciones por OMR.

CRITERIO	ORIENTACIÓN	EVIDENCIA SUGERIDA
	normas nacionales o internacionales, como las de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente de la OMS, Sociedad Argentina de Infectología, CDC, OPS, NICE, etc.	
4.4l) Se controlan los planes de vacunación de pacientes y personal mediante actividades normatizadas.	4l) En todos los pacientes, tanto en ambulatorio como en internación y en el personal, - Se controla el cumplimiento de los planes de vacunación estándares y especiales, - Se procede a la vacunación de las personas y de los grupos de riesgo que hayan sido detectados, cuando ello es pertinente. - Se registran las vacunaciones efectuadas. Las normas establecen los mecanismos de evaluación y control de los esquemas vacunatorios, así como de la vacunación de grupos especiales de riesgo.	4l) - Normas activas de control de vacunación de los pacientes ambulatorios e internados. - Registro de vacunaciones.
4.4m) Se desarrollan actividades de capacitación del personal acerca de la prevención de infecciones.	4m) Las actividades son periódicas y alcanzan a la totalidad del personal, aunque se adaptan a las diferentes características laborales (profesionales, no profesionales, actividades asistenciales, administrativas y/o de apoyo, etc.) y contienen específicamente temas de - Higiene de manos; - Uso, manipulación y descarte de descartables y consumibles; - Prevención de infecciones en el sitio quirúrgico;	4m) - Programa de capacitación del personal en temas de prevención de IACS.

CRITERIO	ORIENTACIÓN	EVIDENCIA SUGERIDA
	- Utilización de elementos de protección personal; - Conducta en oportunidad de la atención de pacientes en situación de aislamiento. - Gestión de residuos biopatogénicos.	
4.4n) Los casos de enfermedades infecciosas son notificados a las autoridades según el marco legal vigente.	4.4n) La Ley 15.465 [74], establece las patologías infecciosas pasibles de notificación obligatoria, para lo cual el establecimiento ha desarrollado e implementado un procedimiento específico.	4.4n) - Procedimiento de notificación de casos de enfermedades infecciosas. - Ejemplos de notificaciones efectuadas.

CONFIDENCIAL